

基于系统中医探讨形气神一体化的内涵及临床意义

张亚鹏 孙霄 祝广钦 王乐鹏 孙一珂 王若冲 张海蓉 李婉君 马淑然

【摘要】 本文立足于系统中医的元整体原理,深入探讨形气神一体化理论的科学内涵及临床应用。本研究认为,形气神一体化理论的实质是把人作为元整体构筑的“物质—能量—信息”一体化框架,其生理内涵是“物质—能量—信息”这一生命活动的有序稳态,而病理内涵则是其失序失稳。在系统中医元整体原理指导下,形气神一体化思想可以有效指导临床诊疗,阐释疾病的病理演变,应用于疾病诊断的整体分析,并在系统性疾病调治中发挥重要作用。形气神一体化强调形气神相互作用与平衡是维护人体健康的关键,不仅为疾病诊断和治疗提供重要指导,也为养生提供理论基础,从而有助于更准确地把握疾病的病理本质,并制定更为全面有效的治疗策略。文章提倡在诊疗过程中依托气化理论进行察神、调气、调形的一体化临床实践。运用形气神一体化的新思维模式,凸显了人体元整体性在临床病理分析、诊断与治疗指导中的重要作用。

【关键词】 系统中医; 人的整体性; 元整体原理; 形气神一体; 物质—能量—信息

【中图分类号】 R223 **【文献标识码】** A doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2024.11.015

Exploring connotation and application of form, *qi* and spirit based on systematic traditional Chinese medicine

ZHANG Yapeng, SUN Xiao, ZHU Guangqin, WANG Lepeng, SUN Yike, WANG Ruochong, ZHANG Hairong, LI Wanjuan, MA Shuran

School of Traditional Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China

Corresponding author: MA Shuran, E-mail: mashuran64@sina.com

【Abstract】 Based on the holistic principles of Systematic Traditional Chinese Medicine (TCM), this paper explores the scientific connotations and clinical applications of the theory of the unity of form, *qi*, and spirit. This study suggests that the essence of the unity of form, *qi*, and spirit lies in constructing an integrated ‘matter-energy-information’ framework with humans as a holistic entity. Its physiological connotation is the orderly homeostasis of this life activity, while its pathological connotation is the loss of this order and stability. Guided by the holistic principles of Systems TCM, the concept of the unity of form, *qi*, and spirit can effectively guide clinical diagnosis and treatment, explain the pathological evolution of diseases, provide an overall analysis in disease diagnosis, and play a crucial role in treating systemic diseases. The unity of form, *qi*, and spirit emphasizes the interaction and balance between form, *qi* and spirit in maintaining human health. It not only provides essential guidance for disease diagnosis and treatment but also forms the theoretical foundation for health preservation, thus enabling a more accurate understanding of the pathological essence of diseases and the development of more comprehensive and

基金项目:国家自然科学基金(82274385)

作者单位:102488 北京中医药大学中医学院[张亚鹏(博士研究生)、孙霄(硕士研究生)、祝广钦(硕士研究生)、王乐鹏、孙一珂(博士研究生)、王若冲(博士研究生)、马淑然];烟台毓璜顶医院中西医结合科(张海蓉);北京市丰台中西医结合医院(李婉君)

作者简介:张亚鹏(1990-),2021 级在读博士研究生。研究方向:中医基础理论与临床应用研究。E-mail: zhangyapeng@bucm.edu.cn

通信作者:马淑然(1964-),博士,教授,博士生导师。研究方向:天人相应理论与临床实验研究。E-mail: mashuran64@sina.com

effective treatment strategies. This paper advocates integrating the unity of form, *qi*, and spirit into clinical practice based on the theory of ‘*qi* transformation’ to observe the spirit, regulate energy, and adjust form in a unified approach. The application of an integrated new mindset involving form, *qi*, and spirit highlights the crucial role of the holistic nature of the human body in clinical pathological analysis, diagnosis, and treatment guidance.

【Key words】 systematic traditional Chinese medicine; holism of humans; meta-integrity principle; integration of form, *qi* and spirit; matter-energy-information

系统中医作为中医学与系统科学的交叉学科,旨在探讨人类生命的复杂性及其与健康与疾病之间的关系。系统中医提出 7 大原理,其中元整体原理揭示了人作为复杂的开放巨系统的本质特征,提出人体既是一个分化系统,也是一个统一的整体。这一原理要求在全面理解人体的分化机制和整体特性的基础上,深入分析并调整健康与疾病的状态^[1]。元整体原理通过形、气、神三个维度来认识和治疗疾病,强调人体是一个不可分割的有机整体。在此框架下,形气神构成了一个不可独立分割的统一体系。具体来说,元整体是原生的、第一性的,形、气、神分别是元整体派生的、第二性的,在元整体中分工合作,不可分离。因此,在生理、病理的诊断与治疗过程中,必须采取一体化的调治策略,以符合元整体的本质。任何割裂其有机关系的调治方法都难以实现最佳的整体目标。尽管形气神一体化理论已在肿瘤^[2]、心脏病^[3]、胃炎^[4]等疾病的临床治疗中得到一定应用,但其深刻的科学内涵及临床应用机制仍需进一步探讨和阐释。因此,有必要基于系统中医元整体原理,探讨形气神一体化整体调治的科学内涵及临床意义。

1 中医学对形气神的认识

中医学认为形是生命的本原,气是动力,神则是生命活动的体现和主宰。三者相互依存,正如《类证治裁·内景综要》所说“一身所宝,惟精气神。神生于气,气生于精,精化气,气化神”,强调了形神合一是生命存在的根本保证^[5]。此解释虽然正确描述了形气神之间不可分离,相互化生,但无法深刻阐释形气神三位一体状态的整体性和连续性的内在机制。在《淮南子》中有“形者,生之舍也;气者,生之充也;神者,生之制也。一失位则三者伤矣”之说,从中可以看出人体不仅是固定的器官组合,更是形、气、神三者和谐统一的有序动态稳定系统,明确了形气神的相互作用关系^[6]。章文春^[7]首次提出了形气神三位一体生命观的概念,认为三者

是构成人体生命的基本要素。尽管如此,形气神一体化理论的深刻内涵及机制尚未完全阐明。临床上,基于形神一体观治疗癌症^[8-9]的临床应用较多,而在针灸治疗中过分强调“得气”^[10]而忽略形气神整体作用的情况也存在。在心理和精神状态的“神”方面的研究尤其存在不足^[11]。因此,将形气神一体化从理论转化为临床实践仍面临挑战,需要更多研究验证其效果和价值。

2 元整体原理为形气神一体化理论提供新视角

2.1 形气神一体化理论本质为“物质—能量—信息”一体化系统架构

元整体原理将人视为自然、社会、心理、生物属性的统一体。在疾病认识上,元整体原理认为六淫、七情内伤、内生五邪亦不是独立的致病因素,而是与人体形气神综合调治相关,“和”则为正,“不和”则为邪。在健康观、疾病观和防治观上,元整体原理主张通过形气神一体化进行全面的疾病预防和治疗。系统中医视人为复杂开放巨系统,内外气机交换维持生命稳态。如《素问·五常政大论篇》云“根于中者,命曰神机,神去则机息。根于外者,命曰气立,气止则化绝”,说明气立所化之神也应有四时之变,才能有形体的生长壮老已的生命历程。现代研究指出,气具有高度的能量属性,其物质基础可能是机体的电磁场,这在现代科技层面为中医的气理论提供了科学解释^[12]。神携带着生命信息,具有表达、处理生命信息与调控生命活动的作用^[13]。形气神理论将物质、能量、信息融为一体,其中气不仅是形与神的联系纽带,还是在持续的气化过程中形与神的相互作用和信息交换的媒介^[14]。形气神变化为疾病内在机制,任一要素变化均可影响其他要素^[15]。形变表现为物质的改变,如脉筋肉皮骨、脏器组织和津血的病变;气变影响生理能量,如气机、气化异常;神变则关联精神和心理状态,如五脏精气亏虚导致五脏功能失常,继而影响心理活动出现五神(神魂魄意志)、五志(喜怒思忧恐)的变

化。反之,五神、五志异常也会导致五脏气机失常,进而影响津血循行,出现痰饮、水湿、瘀血等形变。

2.2 形气神一体化的生理内涵实质是“物质—能量—信息”这一生命活动的有序稳态

祝世讷教授^[16]指出人的生命系统自我调节、自我更新、自我复制的自组织系统,形气神是实现生命活动自我调节和自我组织的核心。在这一理论框架中,形体不仅是生命活动的载体,其健康与完整性对维持正常生理功能至关重要。形体的健壮体现在结构完整、气充盈、神旺盛;反之,形体衰弱则气虚弱、神衰。气的变化和运动推动生命进程,对人体的健康和疾病起着核心作用。神为人体生命活动的表现和主宰,广义之“神”指人的全部生命活动,涵盖人外在表现和对外界事物的反应能力,狭义之“神”指精神、意识和思维活动^[17]。神的健康状态直接影响生命系统的自组织能力和整体健康^[18]。

现代医学研究表明,生命系统的健康不仅是形(物质)、气(能量)、神(信息)各自的健康,还包括其关系随自然界变化的有序稳态。“有序”是形气神各自活动维持一定的层次秩序,“稳态”强调三者之间在伴随宇宙节律变化中,在一定限度内保持生理的有序动态稳定。就形(物质)而言,心肺居上,肝脾居中,肾肠膀胱居下,位置秩序不能颠倒,这是形自身的有序;同时,天有十二月,人有十二关节,天有二十四节气,人有二十四节脊柱骨,天有日月,人有两目等等,这是人天同构的秩序;就气(能量)而言,整体气机有序稳态,局部气机各有偏重,如心肺气机宜降,肝肾气机宜升,脾升胃降,协调有序。如《素问·刺禁论篇》:“肝升于左,肺藏于右,心部于表,肾治于里,胃为之市。”^[19]同时,一年四季春生、夏长、长夏化、秋收、冬藏,人亦应之,这是气机气化的人天同气。就神(信息)而言,五志五神分别对应五脏,这是形神关系的秩序。《素问·四气调神大论篇》言春季“生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚”、夏季“若所爱在外”、秋季“收敛神气”、冬季“若有私意,若己有得”,这是四季调神的人天同律的有序稳态原则。可见,人是宇宙母系统的子系统,不但自己要维持内在的有序稳定,还要与宇宙的节律保持同构、同气、同律的有序稳定。

2.3 形气神的病理内涵实质是“物质—能量—信息”这一生命活动的失序失稳

系统中医学认为病变本质是以形气神为核心

形成的复杂关系网失调。薛定谔指出“生命以负熵为食”,人体作为典型的耗散结构,依赖负熵过程维持生命活动。玄府气化不利导致气血精津流动和神机的无序是疾病根源^[20]。耗散结构的形成依赖于系统正确和充分开放性,生命活动依赖于同外界进行物质、能量、信息交换。人体具有自我恢复平衡的能力^[21],但形气神关系一旦被割裂,就会影响到生命的自我更新、自我复制和自我调节等自组织能力。形体的损伤或疾病的侵袭可以导致气血耗损,气不畅则进一步影响形体功能,神不调则影响精神状态,这些因素相互作用,进一步影响形体和气的功能。因此,形气神的失调是生命活动失序失稳的关键因素。如本团队研究指出,交节病的产生是机体“增熵减序”的结果,说明机体有序度下降和熵增加是疾病产生的根源所在^[22]。可见形气神的各自或其关系失常可以导致人体出现各种症状,其实质是“物质—能量—信息”一体化系统架构失稳。

3 系统中医学元整体原理指导下的形气神一体化思想可以有效指导临床诊疗

中医学的元整体原理强调形气神在生命活动和疾病诊治中的核心作用^[23],强调以整体辨证和动态有序视角理解健康与疾病,关注形体结构变化及气和神对健康的影响。在诊疗实践中,遵循元整体原理至关重要,应从形气神一体化的视角出发,确保三者在治疗各个阶段的协同作用。因此,医生应采取多元化的治疗策略,通过形气神一体化的整体诊疗方法可以有效提升对临床疑难杂症的治疗效果。

3.1 从形气神一体化阐释疾病的病理演变

系统中医学认为疾病本质是功能性的,形气神关系失调为疾病发生的关键。在人体系统中,存在元整体功能和器官负载的“官能”,从系统中医学角度来看,元整体功能的失调和结构的异常是疾病的根本原因。疾病首先是功能性的问题,而器质性疾病则是由此派生,其次才是器质性疾病负载的官能失常。如“大凡形质之失宜,莫不由气行之失序”说明器质性疾病是源于气化功能失常。而《素问·阴阳应象大论篇》所言“故先痛而后肿者气伤形也,先肿而后痛者形伤气也”说明形态结构异常(肿)与功能变化(气机失常)又是相互影响的。《素问·阴阳应象大论篇》言“人有五脏化五气,以生喜怒思忧恐”,说明五脏气化导致情志异常;反之,五志异常

也会损伤对应脏腑。可见,在疾病的演变过程中,形气神三者的地位并不等同,其中最核心的环节是“气行之失序”,这是导致神与形异常的关键因素。《素问·举痛论篇》云“百病皆生于气”,强调气机不畅是功能紊乱和疾病发生的主要原因^[24]。《素问·生气通天论篇》言“营气不从,逆于肉理,乃生痈肿”,则明确了功能异常导致结构失稳的病理过程。通过深入理解形气神的相互联系及其在疾病中的作用,可以更有效地揭示疾病的发生演变机理,尤其是器质性、功能性疾病及神病的关系,从而弥补中医病理学研究的不足。

3.2 形气神一体化思想在疾病诊断中的整体应用

在系统中医视角下,人体被视为一个整体,强调在诊断中同等重视对形气神的观察。望诊的方法涵盖望神、望色、望形体,通过观察人体的形气神变化,“以表知里”,即通过表面现象推断内部功能状态的异常,进而进行“辨证”即诊断功能状态的异常。然而,临床常见问题是“按手不及足”“按足不及手”,或察神不察气形,或察气形不察神,难以达到对形气神三者同等重视的境界。《难经》曰:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧。”这一神、圣、工、巧的等级秩序划分,体现出察神、气、形的等级秩序不同和重要程度不同,强调诊断中特别关注气化所表现的信息,为临床上形气神的综合观察提供了重要指导。

3.3 形气神一体化策略在系统性疾病调治中的实践

在中医临床实践中,疾病的病因和病机往往十分复杂,常见为神病影响气和形,以及形气病影响神志,这导致病程延绵难愈,治疗过程尤为棘手。在治疗策略上,应根据形气神失序的具体顺序,选择性地确定调节形气神的先后次序。先调形,如《素问·生气通天论篇》提出“骨正筋柔,气血自流”,强调通过调整筋骨结构恢复平衡和气血流动^[25],其治法有浮针、正骨、理筋、按摩等;先调气,如《庄子集释》^[26]曰:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死”,表明气的充盈流通与健康密切相关,治法有针灸、吐纳、气功等;先调神,治神为针灸治疗原则之一,如《素问·宝命全形论篇》说“凡刺之真,必先治神”,强调针刺时注重调神、察神的重要性。《灵枢·官能》曰“用针之要,无忘其神……可使行针艾”,提示在施行针灸前需使病人情绪安定,以促进治疗效果^[27]。其治法有针灸、祝由等调

神措施。同调形气神,如 Lowen A^[28]指出负面情绪与形体姿势紧密相关,强调手法治疗师和心理学家协同解决运动障碍和情绪问题。有研究发现,手法治疗可改善心理状态及焦虑^[29]。

4 验案举隅

患者,男,2024 年 3 月 1 日首次就诊。主诉肢体皮疹伴关节疼痛 5 月余。患者 5 个多月前无明显诱因出现足底水泡伴疼痛,颈部及双侧肘部疼痛。实验室检查显示红细胞沉降率、C 反应蛋白水平均升高,骨扫描和关节超声检查提示胸锁关节和左侧第二胸肋关节血供丰富、胸锁关节炎性骨侵蚀、左膝滑膜炎。西医诊断为 SAPHO 综合征,中医诊断为痹证。初诊以理气为要,兼调神、形。处方补中益气汤合甘露消毒丹加减,合方起到调理脏腑气化、改善异常功能状态的目的。同时进行心理疏导,缓解患者心理压力和焦虑紧张,并嘱咐患者外用该方泡浴调形。二诊以复形为主,兼治气、神,结合中医外治法,以图先祛其有形之邪,则无形之气机失调则易除。通过浮针疗法改善肌肉的缺血状态,扫散调整皮下疏松结缔组织的空间结构,改善肌肉挛缩状态^[30]。三诊以调神为首,同调气、形,针刺百会、神庭、神门、内关、合谷、太冲,调理形气神关系。患者接受形气神一体化同调治疗后症状显著改善。这例临床案例充分证明了形气神一体化调治策略在复杂系统性疾病中的有效性。通过调理形气神的整体关系,全面改善患者临床症状,激发其自愈能力,实现整体康复,为多系统复杂性疾病诊疗提供了新思路。

5 结语和展望

本研究基于系统中医元整体原理,深入探讨了形气神一体化的科学内涵及其在临床实践中的应用价值。形气神一体化不仅为疾病的复杂性提供了全面的解释框架,还强调了身心整合在治疗功能性和情感类疾病中的重要性。研究强调,未来的临床应用和理论探索应更多关注“气”和“神”的作用,探索其在调节心理生理状态中的具体机制,及其对身体健康的影响。此外,形体结构与气机功能在疾病进展中的相互作用也是未来研究的重要方向。建议未来研究应侧重于临床试验和案例研究,应在系统中医元整体原理指导下,以形气神一体化视角设计大样本的随机对照研究,报告应遵循

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 标准^[31]。这一做法将为形气神一体化的诊疗方案提供坚实的科学依据,同时丰富中医在现代医学领域的应用。通过这种研究方法,不仅可以为现代医学提供创新的治疗策略,而且能够从理论上进一步深化对传统中医“物质—能量—信息”系统架构的理解。

参 考 文 献

- [1] 祝世讷. 中医系统论基本原理阐释[J]. 山东中医药大学学报, 2021, 45(1): 7-21.
- [2] 张若琪, 张培彤, 王璐瑶, 等. 张培彤教授从形气神一体观论治肿瘤相关性抑郁经验[J]. 中国医药导报, 2023, 20(30): 134-137, 142.
- [3] 袁漂, 孟伟, 郑清华, 等. 郭维琴教授“形气神”一体同调论治冠状动脉粥样硬化性心脏病经验[J]. 环球中医药, 2023, 16(8): 1584-1587.
- [4] 上官雪丽, 朱莹. 朱莹教授从“形气神一体同调”论治慢性萎缩性胃炎经验[J]. 云南中医中药杂志, 2023, 44(6): 14.
- [5] 郑洪新, 杨柱. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021: 102-105.
- [6] 王健. 《淮南子》的生生身体观论析[J]. 周易研究, 2023(5): 14-26.
- [7] 章文春. 基于形气神三位一体生命观的气功修炼理论研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2010.
- [8] 莫郑波, 项琼, 宋恩峰. 基于“形神一体观”探讨中晚期肝癌辨治[J]. 中医临床研究, 2024, 16(1): 55-59.
- [9] 李经蕾, 侯炜. 基于“形神一体观”论治癌症相关性疲乏[J]. 北京中医药大学学报, 2023, 46(9): 1313-1318.
- [10] 王祯珍, 卢云霄, 郝峻. 基于“形气神”理论探讨针灸诊疗中的相关要点[J]. 湖南中医杂志, 2023, 39(10): 99-103.
- [11] 侯学思, 赵吉平, 白鹏, 等. 浅析“形气相合”对针灸临床诊治的指导作用[J]. 针灸临床杂志, 2018, 34(3): 14.
- [12] 韩金祥, 韩奕. 论中医气的物质基础是机体辐射电磁(量子)场[J]. 山东中医药大学学报, 2010, 34(6): 474-476, 479.
- [13] 王文炎, 陈瑞, 梁凤霞. 中医“神”的探析与思考[J]. 中医学报, 2021, 36(10): 2051-2054.
- [14] 薛小虎, 李博成, 孙泽佳, 等. 形气神关系及其实践意义再探[J]. 江西中医学院学报, 2012, 24(2): 1-3.
- [15] 马幸福, 苏毅, 郑智文, 等. 背肌筋膜炎中医治疗进展[J]. 中医临床杂志, 2018, 30(11): 2145-2148.
- [16] 祝世讷. 中医系统论与系统工程[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 309.
- [17] 邱烈泽, 章文春. 《黄帝内经》形气神三位一体生命观之神探析[J]. 江西中医药, 2017, 48(9): 11-13.
- [18] 黄剑. 《黄帝内经》养生方法探讨[J]. 河南中医, 2008, 28(4): 8-9.
- [19] 黎敬波. 对“肝生于左, 肺藏于右, 心部于表, 肾治于里, 脾为之使, 胃为之市”的理解[C]//中华中医药学会. 中华中医药学会第十六次内经学术研讨会论文集, 2016: 1.
- [20] 张海蓉, 朱佩, 孙一珂, 等. 从玄府为人体耗散结构之基论治癌病[J]. 中华中医药杂志, 2023, 38(3): 1061-1064.
- [21] 张敬文, 章文春. 中医藏象学说自组织原理探析(二)——从耗散结构的形成条件探讨藏象与养生[J]. 中医学报, 2012, 27(2): 176-177.
- [22] 张海蓉, 孙一珂, 孙霄, 等. 从系统自组织演化探讨交节病的发病与防治[J]. 中医杂志, 2023, 64(2): 114-118.
- [23] 肖微, 周俊. 试论形气神与针灸治疗的关系[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(10): 4926-4928.
- [24] 胡慈姚. 论“百病生于气”与气机理论的临床价值[J]. 中华中医药杂志, 2007, 22(6): 392-394.
- [25] 张旭明, 王海东, 王婷婷, 等. 基于形气神理论探讨膝关节炎的针刀诊疗思路[J]. 风湿病与关节炎, 2022, 11(11): 60-62, 67.
- [26] 清·郭庆藩. 庄子集释[M]. 王孝鱼, 点校. 北京: 中华书局, 2012: 730.
- [27] 高忻洙, 胡玲. 中国针灸学词典[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2010: 464-607.
- [28] Lowen A. Bioenergetics: An interview with Dr. Alexander Lowen of New York. Interview by M. Carafa[J]. Minerva Psichiatr, 1979, 20(2): viii-xi.
- [29] Fernández-Pérez A M, Peralta-Ramírez M I, Pilat A, et al. Effects of myofascial induction techniques on physiologic and psychologic parameters: a randomized controlled trial[J]. J Altern Complement Med, 2008, 14(7): 807-811.
- [30] 王茱蕾, 马力群, 李华. 浮针疗法联合推拿治疗慢性非特异性腰痛气滞血瘀证 46 例[J]. 环球中医药, 2022, 15(3): 511-514.
- [31] 刘建平. 中医药临床试验的方法学问题与挑战: 循证医学的观点[J]. 中西医结合学报, 2006, 4(1): 1-6.

(收稿日期: 2024-03-27)

(本文编辑: 张楠)